Validez interna

Nombre: _____

Fecha: _____

Ejemplos ilustrativos del Instituto de Salud del Estado (ISES) de Luvina. Escriba sus respuestas o elija una opción y compare con su facilitador.

Parte A. Pérdidas al seguimiento

Un ensayo de T frente a R asignó al azar a 250 pacientes a cada grupo. Abandonaron 50 pacientes del grupo T (35 de ellos por falta de respuesta) y 20 pacientes del grupo R.

1. Porcentaje de pérdida en el grupo T

Respuesta: _____ %

2. Porcentaje de pérdida en el grupo R

Respuesta: _____ %

3. Porcentaje de pérdida total del ensayo

Respuesta: _____ %

4. Diferencia de pérdida entre los grupos

Respuesta: _____ puntos porcentuales

5. ¿Qué señal de alerta aparece?

- ☐ Ninguna, porque la pérdida total es menor de 20%.
- ☐ La diferencia entre grupos supera 10 puntos porcentuales y la mayoría de los abandonos de T se deben a falta de respuesta.
- ☐ Solo la pérdida total, porque supera 10%.

6. Un análisis por protocolo incluiría solo a los 200 pacientes de T y a los 230 de R que completaron el estudio. ¿Qué efecto tendría ese análisis sobre la estimación del beneficio de T?

- ☐ Sobrestima el beneficio de T, porque salen de T los pacientes que no respondían.
- ☐ Subestima el beneficio de T.
- ☐ No cambia nada, porque los dos grupos pierden pacientes.

Parte B. Las cuatro preguntas

Otro ensayo de T frente a R asignó el grupo según el número de expediente: pares a T y nones a R. Pacientes y evaluadores sabían el grupo. El desenlace principal fue la calidad de vida que reporta el paciente. El análisis principal incluyó solo a quienes tomaron más de 80% de las dosis.

7. ¿Qué falla tiene la asignación?
   - ☐ Ninguna, porque pares y nones se reparten por igual.
   - ☐ Solo un problema de tamaño de muestra.
   - ☐ La secuencia es predecible: quien recluta sabe qué grupo toca y puede elegir a quién incluir.

8. Con la calidad de vida como desenlace y un estudio abierto, ¿qué sesgos preocupan más?
   - ☐ Los sesgos de desempeño y de detección.
   - ☐ El sesgo de deserción.
   - ☐ Ninguno, porque la calidad de vida es un desenlace objetivo.

9. ¿Qué se concluye del análisis principal?
   - ☐ Está bien, porque mide el efecto en quienes sí tomaron el tratamiento.
   - ☐ Es un análisis por protocolo; el análisis principal debió ser por intención de tratar, con todos los aleatorizados.
   - ☐ Es un análisis por intención de tratar.

10. Un estudio abierto es inválido por definición.
    ☐ Verdadero ☐ Falso

11. En un estudio abierto, el riesgo de sesgo de detección es menor si el desenlace es la mortalidad que si es el dolor.
    ☐ Verdadero ☐ Falso

Diplomado en Economía de la Salud y Evaluación de Tecnologías Sanitarias, Pulso. La explicación completa está en la página de la unidad U08.